

Summary:

根據病歷資料，陳彥妤入院前的主要病史與治療歷程如下：

- 2025年5月 (手術)：於2025年5月21日，於左前臂進行肺泡狀橫紋肌肉瘤切片與減積手術。
- 2025年6月 (化學治療)：於2025年6月2日，依據 TPOG RMS HR 2016 計畫啟動化學治療。
- 2025年10月 (放射線治療)：於2025年10月22日至12月10日，對左前臂腫瘤床實施5040cGy於28次分割的放射線治療；同時於10月22日至12月3日，對左腋下淋巴結施行4140cGy於23次分割的放射線治療。
- 2026年2月 (化學治療)：於2026年2月13日至14日，接受第35週的 VAC 化學治療 (含 Vincristine、Cyclophosphamide、Dactinomycin)。
- 2026年3月 (化學治療)：於2026年3月6日至7日，接受第38週的 VAC 化學治療 (含 Vincristine、Cyclophosphamide、Dactinomycin)。

病患陳彥妤的主要診斷與治療過程詳述如下：

一、主要診斷

1. 肺泡狀橫紋肌肉瘤 (Alveolar rhabdomyosarcoma)，左前臂，IRS 第 IV 群，TNM 第 4 期，疑似轉移至 T1、L3 脊椎、右骨盆骨與左腋淋巴結，已於 5/21 切片與減積，依 TPOG RMS HR 2016 方案 (自 2025/6/2 起)，已於 2026/4/8 第 41 週接受 VAC 化學治療，2026/4/15 第 42 週接受 V (Vincristine) 化學治療，已於 2025/10/22-12/10 於左前臂腫瘤床接受放射線治療 5040cGy/28 次，左腋淋巴結 4140cGy/23 次，並於 2026/4/13 起於 T9 (及疑似 T1、T3、L3) 部位接受放射線治療 3Gy/10 次 (至 2026/4/27 完成)，左大腿、左背部、左臂皮下有多處疑似轉移，使用 everolimus 1# qod 與 alpelisib 1# qod (自 2026/4/24 起)，基於 NGS (PIK3CA H1047R，證據等級 3A)。
2. 下半身癱瘓 (Paraplegia)，伴下肢運動神經缺損與麻木，T9 壓迫性骨折伴脊髓壓迫，已於 3/25 施行椎板切除 (Laminectomy) 與減壓 (Decompression)，腫瘤復發與進展於 2026/4/15 MRI 顯示。
3. 疑似 Jeavons 症候群，於 9/12 發作癲癇，使用 Levetiracetam 1# TID。
4. 左手下垂，與腫瘤壓迫相關，接受復健。
5. 抑鬱，使用 alprazolam 0.125mg BID 與 fluoxetine 1# QOD。
6. 潛在疾病。

二、入院原因 (2026/03/22)

患者主訴雙側腰部疼痛持續兩天，伴隨下肢麻木與無力自昨日起 (Bilateral flank pain for 2 days, with lower limb numbness and weakness since yesterday)。臨床檢查發現下肢運動功能下降與感覺異常，符合下半身癱瘓徵象，與 T9 壓迫性骨折導致脊髓壓迫 (Spinal cord compression) 相關。影像學於 2026/03/24 之胸部正位顯示右鎖骨下途徑植入化療港 (Port-A)，尖端位於上腔靜脈；2026/03/25 之胸椎正位顯示下胸椎已有器械固定，提示先前已對 T9 壓迫性骨折進行固定術。入院後於神經外科住院觀察，當日未給予特定藥物治療，僅安排住院觀察與後續評估。

三、治療過程

- 手術與術後併發症 (3/25 - 3/27)：於 3/25 進行 T9 病理性骨折減壓手術 (Decompression) 後，患者的四肢無力與感覺異常初步改善。3/27 出現短暫性低血壓，因而調整鴉片類止痛藥劑量 (opioid analgesics)，具體劑量未提及。
- 腸道管理與止痛調整 (4/2 - 4/6)：4/02 轉至普通病房後，主要處理腸道慣性蠕動減弱 (adynamic ileus) 與神經性腸道功能障礙 (neurogenic bowel)。4/06 停止使用 morphine，改以促動劑 Primoren、Mosapride (劑量未提及) 逐步緩解腹痛。

- 置管與電解質補充 (4/7 - 4/9): 4/07 移除手術縫線與中心靜脈壓測線 (CVP line), 同時建立 Port-A (人工血管) 以供長期藥物輸注。因檢測到低鎂血症 (hypomagnesemia), 於同日開始口服 MgO 補充 (劑量未提及)。4/08 因間歇性上腹痛開始使用質子泵抑制劑 (PPI) (劑量未提及), 4/09 進行胃腸科會診。
- 化療重啟與影像評估 (4/8 - 4/10): 4/08 恢復 VAC 化學治療方案 (由 Vincristine、Cyclophosphamide、Dactinomycin 組成), 同時安排放射線治療 (Radiotherapy) 模擬。4/10 腹部超音波顯示少量腹水、部分糞便與腸道蠕動正常。
- 骨髓抑制與血液製品需求 (4/11 - 4/17): 4/11~4/17 期間出現嚴重化療誘發的血球減少, 血小板最低 11K、血紅素 Hb 最低 7.3 g/dL, 需輸注紅血球濃縮液 (PRBC) 與血小板製劑 (具體次數未提及)。4/12 活動後突發下半身癱瘓 (paraplegia)。4/16 MRI 確認 T9 椎體腫瘤進一步增大。4/17 發生嗜中性白血球低下發熱 (neutropenic fever), 即刻開始使用 tazocin 與 gentamicin (GM) (劑量未提及), 同日至 4/18、4/20 進行血液製劑輸注。
- 感染管理與血球恢復 (4/17 - 4/20): 4/17~4/20 期間因 neutropenic fever 採取廣譜抗生素 tazocin 與 GM 治療, 血培與尿培均為陰性。4/20 血液學最低點為白血球計數 WBC 0.31 K (ANC <100), 伴隨血氣分析顯示 BE(b) 2.7 mmol/L、-3.2 mmol/L, 血糖 Finger sugar 67 mg/dL。於此期間使用白血球生成刺激劑 G-CSF (劑量未提及), 使 WBC 於 4/22 回升至 3.15 K。
- 放射治療與標靶治療介入 (4/22 - 4/24): 4/22 放射線治療因血球減少暫停後恢復, 並於同日完成次世代定序 (NGS) 顯示 PIK3CA H1047R 突變。4/23 重啟放射後出現顯著肋骨疼痛與喉嚨痛。4/24 基於 NGS 結果, 開始標靶治療, 使用 everolimus 與 alpelisib (劑量未提及), 兩藥交替每兩天一次 (qod)。
- 持續放射治療 (4/24 之後): 放射線治療持續進行, 以控制症狀並緩解腫瘤相關疼痛, 預後仍因腫瘤快速復發而不佳。

四、出院前現況

截至2026-04-24, 患者因T9 椎體腫瘤增大顯示疾病進展, 伴隨嚴重骨髓抑制, 血液檢查於04/20顯示白血球計數降至0.31 K, 絕對嗜中性白血球計數<100, 曾發生 neutropenic fever。自04/17起使用 tazocin 與 GM 抗生素治療, 並於04/17-18 及04/20 接受輸血; 放射線治療於04/22 恢復, 同時於04/24 開始標靶治療 everolimus 與 alpelisib。血行動力學狀態資料未提及。出院或轉院計畫未於紀錄中說明, 預計持續住院觀察並安排後續門診追蹤。